

Model poznawczy *paniki*

Błędne koło: odczucie → interpretacja katastroficzna → lęk → silniejsze odczucie. Nie ciało jest problemem, lecz interpretacja.

CZAS: 15 min czytania Fundament terapii **ŹRÓDŁO:** Clark (1986, 1997); Ehlers i wsp. (1993); NICE CG113

JAK UŻYWAĆ

Przejdź **krok po kroku** przez diagram modelu. Następnie wypełnij swoją wersję cyklu na stronie 2 — co konkretnie u Ciebie wyzwało, jakie odczucie, jaka interpretacja, jaka panika. Cel: zobaczyć, że atak nie jest „z niczego” — ma przewidywalną sekwencję, którą można przerwać w każdym ogniwie.

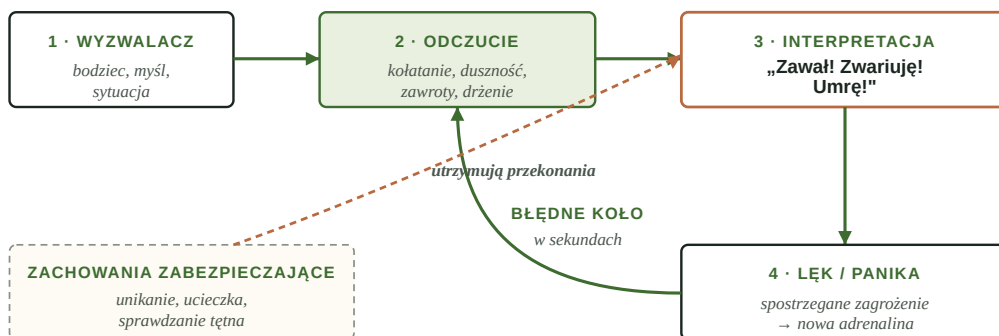
DLACZEGO TO DZIAŁA

Model Clarka (1986) zrewolucjonizował terapię paniki — przesunął fokus z fizjologii na *interpretację poznawczą*. Najważniejszy wniosek: **katastroficzna interpretacja** (ang. *catastrophic misinterpretation*) odczuć cielesnych jest rdzeniem paniki. Terapia poznawczo-behawioralna oparta na tym modelu ma wielkość efektu $d > 1,5$ i jest rekomendowana przez NICE CG113 jako leczenie pierwszego wyboru.

01 ☉ Błędne koło — diagram modelu Clarka

Model Clarka (1986) — błędne koło paniki

Wyzwalacz może być wewnętrzny (kawa, wysiłek, kłótnia) lub zewnętrzny (metro, tłum, wysokość) — sam w sobie nie jest groźny. Mózg **interpretuje** normalne odczucie jako sygnał zagrożenia, co generuje realny lęk i więcej adrenaliny. Koło wzmacnia się samo.



**„DOSTANĘ ZAWAŁU”**

Fakt: serce jest zdrowe — adrenalina je przyspiesza. Limit fizjologiczny 160–180/min. Po EKG zwykle: *bez zmian*. Atak ≠ zawał: brak promieniowania bólu w lewą rękę, brak związku z wysiłkiem.

„ZEMDLEJĘ”

Fakt: w panice ciśnienie krwi *rośnie*, nie spada. Do omdlenia potrzebny *spadek* ciśnienia — odwrotny mechanizm. Zawroty w panice = hiperwentylacja, nie omdlenie.

„ZWARIUJĘ, STRACĘ KONTROLĘ”

Fakt: uczucie nierealności to *derealizacja* — skutek hiperwentylacji. Mija wraz z normalnym oddechem. To **nadmiar** reakcji normalnego systemu, nie psychoza.

„UDUSZĘ SIĘ”

Fakt: hiperwentylacja daje *za dużo* tlenu, nie za mało. Uczucie „brakuje powietrza” jest fałszywym sygnałem — mózg źle interpretuje nadmiar O₂ jako niedobór.

**1 · WYZWALACZ**

— co poprzedziło?

2 · ODCZUCIE CIELESNE

— co konkretnie poczułem/-am?

3 · MOJA INTERPRETACJA

— „boję się, że...” — dosłownie

4 · CO ZROBIŁEM/-AM

— unikanie, ucieczka, sprawdzanie?

Klucz: diagram działa *natychmiast* — gdy widzisz błędne koło narysowane, problem przestaje być „moim ciałem”, a staje się „**moją interpretacją**”. Ehlers i wsp. (1993): wywołanie objawów + edukacja obniża katastrofizację już w jednej sesji. Sama wiedza to za mało — model otwiera drogę do *restrukturyzacji* i *ekspozycji interoceptywnej*, gdzie sprawdzasz nową interpretację w praktyce.